Общий список тем и разделов

Составлено по четырём учебным гайдам: трансплантация печени, абдоминальная хирургия, рак желудка и пищевода, гепатопанкреатобилиарная хирургия.

1. Трансплантация печени
2. Абдоминальная хирургия (6 курс)
3. Рак желудка и пищевода
4. Гепатопанкреатобилиарная хирургия

I. Трансплантация печени — учебный гайд к олимпиаде, 59 стр.

1. **Стратегия и приоритеты**
2. **Программа подготовки с нуля: 11 этапов**
   - Этап 1. Анатомия, физиология, иммунология
   - Этап 2. Цирроз и его осложнения
   - Этап 3. Отбор реципиентов и шкалы
   - Этап 4. Доноры и трансплантаты
   - Этап 5. Консервация и перфузия
   - Этап 6. Операция и анестезия
   - Этап 7. Ранний послеоперационный период
   - Этап 8. Осложнения (главный блок)
   - Этап 9. Иммуносупрессия и отторжение
   - Этап 10. Отдалённый период
   - Этап 11. Практика
3. **База: анатомия, физиология, иммунология**
   - Сегменты по Куино
   - Кровоснабжение
   - Желчные протоки и их кровоснабжение
   - Физиология, важная для теста
   - Иммунология трансплантации печени
4. **Цирроз, Бадда–Киари, холангиокарцинома, лёгочные синдромы**
   - Портальная гипертензия и почки
   - Синдром Бадда–Киари
   - Холангиокарцинома и протокол Mayo
   - Гепатопульмональный синдром и портопульмональная гипертензия
5. **Отбор реципиентов, шкалы, SLK, дети**
   - Показания и противопоказания
   - Шкалы
   - Сочетанная трансплантация печени и почки (SLK)
   - Трансплантация печени у детей
6. **Доноры и типы трансплантатов**
   - Посмертные доноры: DBD и DCD
   - Живое донорство
   - Типы трансплантатов
   - Split-трансплантация
   - Домино-трансплантация

7. **Консервация органов и машинная перфузия**
   - Что происходит при ишемии и реперфузии
   - Растворы для статической холодовой консервации
   - Сравнение методов консервации
   - HOPE: механизм и доказательства
   - NMP: механизм и оценка жизнеспособности
8. **Операция и анестезия**
   - Три фазы операции
   - Варианты кавальной реконструкции
   - Анастомозы
   - Постреперфузионный синдром
   - Инфузионная и гемодинамическая тактика
9. **Ранний послеоперационный период**
   - Ожидаемая динамика при хорошей функции
   - Ранняя дисфункция трансплантата (EAD)
   - Первично нефункционирующий трансплантат (PNF)
   - Алгоритм при ухудшении в первые недели
10. **Сосудистые осложнения**
    - Допплер: нормы и пороги
    - Тромбоз печёночной артерии (HAT)
    - Стеноз печёночной артерии (HAS)
    - Синдром обкрадывания селезёночной артерией
    - Тромбоз воротной вены (PVT)
    - Jump graft
    - Нарушение венозного оттока
11. **Билиарные осложнения**
    - Сравнение основных осложнений
    - Подтекание желчи
    - Анастомотические стриктуры
    - Неанастомотические стриктуры (ишемическая холангиопатия)
    - Гепатикоеюноанастомоз по Ру
    - Т-дренаж
12. **Иммуносупрессия и отторжение**
    - Препараты
    - Взаимодействия через CYP3A4
    - Артериальная гипертензия после пересадки
    - Иммуносупрессия при беременности
    - Отторжение
    - Как различать причины дисфункции
13. **Отдалённый период и особые группы**
    - Хроническая болезнь почек
    - Метаболический синдром и сердечно-сосудистый риск
    - Опухоли
    - Инфекции и вакцинация
    - Беременность
    - Дети в отдалённом периоде
14. **Цифры и пороги для заучивания**

15. **Ловушки и формат «утверждение — причина»**
    - Алгоритм решения
    - Разбор примеров из теста 10.04
    - Типичные ловушки по темам
    - Общие правила выбора
16. **Источники**
17. **Чек-лист и контрольные вопросы**
18. **Финальный тест** (вопросы, ответы и разбор)

II. Абдоминальная хирургия — руководство к экзамену, 6 курс, 17 стр.

Вводные разделы: как пользоваться руководством; общая карта тем; последовательность изучения; приоритетность разделов для теста; фундамент.

- **Этап 1.1. Брюшина, этажи, сумки и каналы**
    - Отношение органов к брюшине
    - Этажи брюшной полости
- **Этап 1.2. Сосудистая анатомия**
    - Непарные висцеральные ветви аорты
    - Воротная вена и её притоки
    - Нижняя полая вена и почечные сосуды
- **Этап 1.3. Забрюшинное пространство: фасции и клетчаточные пространства**
    - Почечная фасция
    - Три клетчаточных пространства
    - Фасции сращения (Тольдта, Трейца, Фреде)
    - Пути распространения жидкости, крови и инфекции
- **Этап 1.4. Поджелудочная железа, ДПК, желчные протоки, терминальная подвздошная кишка**
- **Этап 1.5. Приёмы мобилизации: Кохер, Каттель–Брааш, Мэттокс**
    - Сравнительная таблица
    - Ключевые нюансы
- **Этап 1: схемы для рисования и ориентиры наизусть**
- **Этап 1: что запомнить, типичные ошибки, контрольные задания**
- **Источники к Этапу 1**

Этапы 2–8 в файле есть только в плане, разделов по ним нет:

- Этап 2. Общая патофизиология: SIRS, сепсис, ПОН, гиповолемия, микроциркуляция, транслокация, ВБД, ишемия
- Этап 3. Основные нозологии: острый и хронический панкреатит, язва (перфорация, кровотечение), желчнокаменная непроходимость, перитонит, терминальный илеит
- Этап 4. Классификации и шкалы: ВБГ/АКС, Atlanta 2012, Ishikawa, Bismuth, Strasberg, Гальперин, Мангеймский индекс, Tokyo 2018, Forrest
- Этап 5. Осложнения: псевдокисты, некроз, псевдоаневризмы, сегментарная портальная гипертензия, повреждения протоков, свищи, АКС, осложнения болезни Крона
- Этап 6. Оперативная техника: мобилизация, операции на ПЖ, ушивание язвы, илеоцекальная резекция, шунты, реконструкция протоков, damage control, VAC, эндоскопия, эмболизация
- Этап 7. Лучевая диагностика: КТ, холангиография, фистулография

- Этап 8. Практика: тесты, итоговый тест на 50 вопросов, сводные таблицы, чек-лист

III. Рак желудка и пищевода — гайд подготовки с нуля, 52 стр.

Вводные разделы: как пользоваться гайдом; пошаговый план подготовки; основные источники. В каждой теме также есть подразделы «Тестовые ловушки», «Клинические примеры», «Контрольные вопросы» и «Воспроизвести по памяти», здесь они не повторяются.

1. **Хирургическая анатомия желудка и пищевода**
   - Базовые знания
   - Артерии; артериальные дуги
   - Венозный отток и воротная вена
   - Связки желудка
   - Анатомические ориентиры при гастрэктомии и лимфодиссекции
   - Отделы пищевода
   - Как запоминать станции через анатомию
2. **Лимфатические станции JGCA и объёмы лимфодиссекции при раке желудка**
   - Таблица станций № 1–20
   - Определения D0, D1, D1+, D2
   - Объём лимфодиссекции по типу резекции (JGCA, 6-е издание)
   - Показания к каждому объёму
   - Как определить объём лимфодиссекции по клинической ситуации
3. **Морфология и стадирование рака желудка**
   - Ранний и распространённый рак
   - Парижская классификация (ранний рак, тип 0)
   - Классификация Borrmann
   - Классификация Lauren (1965)
   - Классификация ВОЗ (2019)
   - TNM 8-го издания (AJCC/UICC, 2017)
4. **Молекулярные подтипы TCGA и биомаркеры**
   - Четыре подтипа
   - Биомаркеры, которые определяют лечение
   - Как не перепутать подтип и показание
5. **Хирургическая тактика при раке желудка**
   - Обследование перед выбором тактики
   - Эндоскопическое лечение раннего рака
   - Выбор объёма резекции
   - Реконструкция
   - Комбинированное лечение
6. **Лимфодиссекция и хирургия при раке пищевода**
   - Три лимфатических бассейна
   - Нумерация станций по японской классификации (Japan Esophageal Society)
   - Уровни лимфодиссекции 2S, 2F, 3F
   - Плоскоклеточный рак и аденокарцинома
   - Операции
   - Комбинированное лечение по стадиям

7. **Наследственный диффузный рак желудка (НДРЖ, HDGC)**
   - Патогенез
   - Отличия наследственного рака от спорадического
   - Риски
   - Критерии IGCLC 2020 для генетического тестирования
   - Ведение носителей
   - Разбор клинических ситуаций
8. **Итог подготовки**
   - Тема — что обязательно знать — где читать
   - Выучить наизусть
   - Типичные ошибки на тестах
9. **Итоговый тест**
   - Часть А. Один правильный ответ
   - Часть Б. Утверждение — причина
   - Часть В. Сопоставление
   - Часть Г. Клинические задачи
   - Ответы с разбором

IV. Гепатопанкреатобилиарная хирургия — учебный гайд с нуля, 51 стр.

1. **Дорожная карта подготовки**
2. **Базовая хирургическая анатомия**
   - Сегменты печени по Куино (1957)
   - Глиссоновы ножки и капсула Лаэннека
   - Артерии: чревный ствол, ВБА, аркады
   - Варианты печёночных артерий по Michels (1966)
   - Вены
   - Желчные протоки
   - Поджелудочная железа
   - Схемы для самостоятельной отрисовки
3. **Физиология и лабораторные показатели**
   - Оценка функционального резерва печени
   - Почему это важно для тестов
4. **Лучевая диагностика**
   - Как оценивать сосудистое вовлечение на КТ
   - Клинические примеры
   - Анализ жидкости кист ПЖ при эндоУЗИ
5. **Поджелудочная железа: операции**
   - Стандартная дистальная резекция со спленэктомией
   - Дистальная резекция с сохранением селезёнки
   - RAMPS (Strasberg, 2003)
   - DP-CAR, модифицированная операция Эпплби
   - Сравнительная таблица

6. **Осложнения после резекций ПЖ по ISGPS**
   - Послеоперационная панкреатическая фистула (2016)
   - Постпанкреатэктомическое кровотечение (2007)
   - Гастростаз (2007)
   - Хилёзная утечка (2017)
   - Пострезекционный острый панкреатит, PPAP (2022)
   - Другие осложнения
7. **Заболевания поджелудочной железы**
   - Протоковая аденокарцинома: резектабельность по NCCN
   - CA 19-9
   - Нейроэндокринные опухоли ПЖ
   - Грув-панкреатит
   - Хронический панкреатит: хирургия
8. **Печень: хирургическая анатомия и резекции**
   - Терминология резекций (Брисбен, 2000)
   - Глиссонов подход (Takasaki)
   - Капсула Лаэннека (Sugioka)
   - Как предотвращают кровотечение и повреждение протоков
   - Регенерация и оценка будущего остатка
9. **Пострезекционная печёночная недостаточность**
   - Определение ISGLS (2011)
   - Правило 50-50
   - Оценка до операции
   - Минимальный объём остатка
   - Как увеличить будущий остаток
   - Профилактика и лечение ППН
10. **Кистозные образования печени**
    - Муцинозная кистозная неоплазия печени (МКН)
    - Дифференциальная диагностика
    - Признаки неопластической кисты
11. **Перихилярная холангиокарцинома (опухоль Клацкина)**
    - Классификация Bismuth-Corlette (1975, модификация 1992)
    - Почему тип не равен резектабельности
    - Принципы операции
    - Подготовка
12. **Аномальное панкреатобилиарное соустье и кисты холедоха**
    - Норма и механизм аномалии
    - Критерии диагноза
    - Клиническое значение
    - Классификация кист холедоха по Todani (1977, модификация 2003)
13. **Безопасная холецистэктомия**
    - Треугольники
    - Анатомические ориентиры
    - Критический взгляд безопасности (Strasberg, 1995)
    - Анатомические варианты
    - Если CVS получить нельзя (bail-out)
    - Повреждения желчных протоков

14. **Справочник классификаций и консенсусов**
15. **Алгоритмы принятия решений**
    - Выбор дистальной резекции ПЖ
    - Отделяемое по дренажу после резекции ПЖ
    - Резекция печени
    - Опухоль в головке ПЖ с желтухой
    - Кистозное образование печени
    - Холецистэктомия
16. **Частые тестовые ловушки**
17. **Клинические задачи с разбором** (21 задача и вопросы «утверждение — причина»)
18. **Источники**
19. **План подготовки на 4 недели**